今日論文 • 第 03 篇 需訂閱／付費

中醫運動療法對長者衰弱的效果及運動處方特徵描述：系統回顧與 Meta 分析

Effectiveness of Traditional Chinese Medicine Exercise Therapy for Frailty in Older Adults and Descriptive Summary of Exercise Prescription Characteristics: A Systematic Review and Meta-Analysis

作者	Huang X, Xin B, Wang R, Cui J, Li M, Jiang W, Zhou H
期刊	Journal of the American Medical Directors Association（2026年11月2日線上發表；27卷12期，文章 106521）
識別碼	PMID 42971076 • DOI 10.1016/j.jamda.2026.106521
取用	需訂閱／付費

官方連結（點擊即可打開）

- PubMed 摘要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42971076/
- DOI（出版社全文，可能需訂閱） https://doi.org/10.1016/j.jamda.2026.106521

研究是什麼

系統回顧與 Meta 分析，評估中醫運動療法對 60 歲或以上衰弱、衰弱前期或符合條件的認知衰弱長者，在衰弱相關結局上的效果，並描述運動處方特徵。

方法要點

- 檢索八個資料庫，由建庫至 2026 年 3 月 31 日。
- 納入社區、院舍或臨床場所的隨機對照試驗。
- 兩名研究者獨立篩選、提取資料並評估偏倚風險；對主要結局分別進行隨機效應 Meta 分析，效應量以經 Hedges' g 校正的標準化均差（SMD）表示。
- 共納入 21 項研究，其中 15 項納入主要 Meta 分析。公開摘要未列出總樣本量。

主要結果

- 中醫運動療法對 Edmonton 衰弱量表（SMD 0.55，95% CI 0.04 至 1.06）、Fried 衰弱表型評分（SMD 2.70，95% CI 1.15 至 4.25）、計時起走測驗（SMD 0.75，95% CI 0.17 至 1.33）、Berg 平衡量表（SMD 1.32，95% CI 1.00 至 1.64）及蒙特利爾認知評估 MoCA（SMD 1.02，95% CI 0.63 至 1.41）顯示有利效應。
- 步速無顯著改善；握力僅見較小且不精確的效應。
- 部分結局異質性高。太極與八段錦是最常出現的運動形式；各研究報告的運動處方特徵並不一致。
- 作者認為，中醫運動療法可能有助部分衰弱、活動、平衡及認知結局，但異質性及部分結局證據有限，須謹慎解讀；處方特徵只屬描述性，不能當成已優化的頻率、強度或進階方案。

中醫診所臨床啟示

- 衰弱或衰弱前期長者，可在體力許可下鼓勵練習太極或八段錦，作為平衡及活動訓練的輔助。

- 須按個別體能、跌倒風險及共病調整強度；急性感染、未穩定心肺疾病或嚴重骨關節損傷者，應先經評估。
- 向患者說明：這是綜合分析而非單一標準處方，效果因人而異，不能取代必要的復康或內科處理。

限制與解讀注意

- 公開摘要未提供總樣本量，解讀時須保留此限制。
- 部分結局異質性高，合併效應可能受個別試驗影響。
- 期刊需訂閱，本摘要只根據已核實的 PubMed 摘要撰寫，完整方法學細節請以出版社全文為準。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。